

Información Paciente

Nombre : Juan Gonzalo Pozo Gahona
Edad : 73a 9m 20d
Dirección : Psje Cartagena 596 V. El Arrayan

Rut : 7.036.336-4
Fecha Nacto: 05/02/1952
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1704643
Sexo : Masculino
Teléfono : 222953493

N° Epicrisis
463445

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion

Fecha Ingreso : 25/11/2025 06:41

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Emergencia Adulto

Fecha Egreso : 25/11/2025 12:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

ARRITMIA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente de 73 años
MC: Arritmia cardíaca
Fecha de hospitalización: 25/11/2025

Antecedentes
Médicos: Bypas coronario 2022
Med: bisoprolol, atorvastatina, metformina, hidroclortiazida, aspirina
aqx. by pass coronario, colecistectomía
Alergias: No conocidas
Tabaquismo: suspendido
OH: (-)

EA: Paciente refiere que desde las 17.30 hrs presenta sensación urente en región retroesternal de leve intensidad EVA 2-3/10, asociado a palpitaciones, niega otros síntomas respiratorios, urinarios o gastrointestinales.

Examen físico al ingreso:
Vigil, orientado, llene capilar menor a 2 segundos
yugulares planas
Corazón arritmico, no se auscultan soplos
CP MP (+) SRA
Abdomen RHA (+) BDI sin irritación peritoneal
EEII sin edema, sin signos de TVP

ECG taquicardia de complejo estrecho regular

Evolución:
Paciente en buenas condiciones generales, hemodinamicamente estable, sin requerimiento de oxígeno, sin requerimiento de drogas vasoactivas.
Se administra Lanatosido C, sulfato de magnesio 2g ev, durante observación mantiene FA con respuesta ventricular adecuada.
Estudios de laboratorio dentro de parámetros normales. Historia de dolor atípico asociado a palpitaciones, sin síntomas

Fecha Epicrisis : 25/11/2025 12:57

Fecha Última Actualización: 25-11-2025 12:57:17

Página 2 de 2

respiratorios, gastrointestinales o genitourinarios concomitantes.

Al interrogatorio dirigido paciente relata historia de aproximadamente dos años de evolución de episodios de simiales características con menor duración, hace aproximadamente un mes mas frecuentes y con mayor duración. Se decide inicio de anticoagulación de forma ambulatoria y control con Cardiología.

Exámenes de laboratorio

25-11-2025 7:35:10

na 141 k 4.05 cl 104

ph 7.41 pco2 36.5 hco3 23

hto 40.1 hb 14.2 gb 9.48 plaq 365mil

tp 14.6 inr 1.17 ttpk 29.9

lactico 23.7 crea 0.92 bun 16.7

pcr 3.7

TUS <10

Diagnóstico al alta:

- Fibrilación auricular CHADVSc 2
- Antecedentes

INDICACIONES

- Mantener fármacos de uso crónico
- IC Cardiología
- IC poli de TACO

Diagnóstico de Egreso

Fibrilación auricular -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

ESTABLE

Plan Post Alta

EN EPICRISIS

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

Josefina Hasenberg Letelier

INTERNO



Bec. Xiomara Nataly Defaz Nogale

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 25/11/2025 12:57

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:55

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar